ImunoScan

INVITROCLONE Anti-K (KEL1)

Anticorpos Monoclonais para Tipagem Sanguínea em Tubo

INTRODUÇÃO

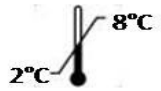
O sistema Kell é o terceiro mais polimórfico sistema de grupo sanguíneo com 28 antígenos. Com exceção do antígeno K (KEL1), que apresenta uma frequência próxima aos 10%, os demais antígenos do sistema são públicos ou privados, entendo-se por "públicos" os antígenos de alta frequência (≥ 99%) e "privados" os de baixa frequência (≤ 1%).
O antígeno K (KEL1) é muito imunogênico e por isso, o anti-K (KEL1) é um anticorpo de frequência importante em politransfundidos e em mães K (KEL1) negativas.

REAGENTES

IVD

O INVITROCLONE Anti-K (KEL1) (clone AEK-4) é um reagente pronto para uso, com anticorpos de classe IgM, preparados a partir de sobrenadantes de culturas celulares de linfócitos B modificados pelo EBV.
Cada lote do reagente é submetido a rigoroso controle de qualidade em vários estágios da produção, para avidez, especificidade e desempenho.

Conservante: < 0,1% NaN3.



Estabilidade: ver prazo de validade no rótulo do frasco.

MATERIAIS E REAGENTES ADICIONAIS NECESSÁRIOS

- Tubos de suspensão (12x75 mm)
- Pipetas Pasteur
- Suporte para tubos
- Incubadora 37º C
- Centrífuga imuno-hematológica
- Aglutinoscópio
- Solução salina isotônica para suspensão de hemácias

PRINCÍPIO

Hemácias humanas portando o antígeno K (KEL1) aglutinarão na presença de anticorpos dirigidos ao antígeno. Aglutinação de hemácias em suspensão com o INVITROCLONE Anti-K (KEL1) indica a presença do antígeno e a ausência de aglutinação indica ausência do antígeno.

OBSERVAÇÕES

1. Reagente laboratorial de uso exclusivo para diagnóstico "in vitro".
2. Contém azida sódica 0,1% como preservativo, portanto, tóxico se ingerido. Evitar contato com mucosas.
3. Forte turbidez pode indicar contaminação bacteriana ou desnaturação térmica do reagente. Nestes casos, descartar o reagente.

COLETA DE AMOSTRA

1. Não requer preparação prévia do paciente para coleta de amostra de sangue.
2. Amostras podem ser coletadas com anticoagulantes: citrato, EDTA, heparina ou CPD-A ou sem anticoagulante.
3. Resultados ideais são obtidos se as provas forem realizadas com amostras recentes.
4. Se os testes não forem realizados imediatamente após a coleta, estocar amostras entre 2-8 °C.
5. Não usar amostras hemolisadas ou contaminadas.

Amostras com anticoagulante devem ser testadas de acordo com seguintes critérios:

EDTA ou Heparina	2 dias
Citrato ou Oxalato de sódio	14 dias
ACD ou CPD-A	28 dias

PROCEDIMENTO

Teste em tubo

1. Todos os materiais e reagentes deverão estar em T.A. antes do uso.
2. Preparar uma suspensão de hemácias a 3% em solução salina isotônica.
3. Identificar o tubo teste com "K" mais o nome ou número da amostra a ser classificada.
4. Pipetar 1 gota (50 μ L) de INVITROCLONE Anti-K (KEL1) no tubo teste.
5. Adicionar 1 gota (50 μ L) da suspensão de hemácias a 3% ao tubo teste e homogeneizar bem.
6. Incubar em 37 °C por 5-15 minutos.
7. Centrifugar por 30-60 segundos a 125 g (1000 rpm) ou de acordo com protocolo estabelecido para a centrífuga em uso.
8. Ressuspender suavemente o botão de células no fundo do tubo e verificar macroscopicamente sinais de aglutinação sobre uma fonte de luz indireta.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Reação positiva (+ a ++++) indica a presença do antígeno K (KEL1).

Reação negativa (sem aglutinação) indica a ausência do antígeno K (KEL1).

OBSERVAÇÕES

1. Baixa centrifugação ou centrifugação excessiva podem produzir resultados errados. Os equipamentos devem ser regularmente verificados em conformidade com os procedimentos de BPL.
2. Controles positivos e negativos devem ser incluídos como recomendados pelos procedimentos de BPL.
3. Após o uso, os reagentes devem ser imediatamente estocados entre 2-8 °C..
4. Reações falso-positivas podem ser produzidas pela presença de aglutininas frias.

REFERÊNCIAS

1. Technical Manual of the American association of Blood Banks, 17th edition, 2011.
2. Human Blood Groups, second edition, Geoff Daniels, Blackwell Science LTD, 2002.
3. Mollison P. L., Engelfried C. P., and Contreras, M.: Blood Transfusion in Clinical Medicine. 10th ed. 1997; Blackwell Scientific Publications, Oxford.
4. Kohler C. & Milstein C. (1975), Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature, 256, 495-497.

APRESENTAÇÃO

INVITROCLONE Anti- K (KEL1)

1 x 5 ml cod. IH.001.30.01

Estes produtos são garantidos quanto ao seu comportamento funcional, tal como descrito no rótulo e no folheto informativo. O fabricante declina toda a responsabilidade decorrente da utilização ou venda destes produtos para fins diferentes dos aqui descritos.

Scan Diagnóstica Ltda – ImunoScan
Rua Governador Valadares,108
São José da Lapa - MG - Brasil
CNPJ: 18.520.715/0001-30
SAC: (31) 3488-1871

MS: 81034870005
RT: Dr. Múcio Figueiredo Vieira -CRFMG -6731
Ver. 03/2019